健康 · 04 · 心脑血管

中风，真的是突然来的吗？

怎样认出、怎样抢时间；上游和上游的上游；中医和自然疗法

约 2.1 万字 · 细读约 45 分钟 · 30 章 · 45 条资料出处

中风看起来总是突然来的：前一天还好好的，第二天早上就拿不住筷子、说不清话。它真的是突然的吗？发病的那一刻，家里人该做什么、不该做什么？医生说中风是“下游”，那上游是什么，上游的上游又是什么？中医、安宫牛黄丸、针灸和各种自然疗法，到底有没有用？这一篇从大脑怎样受伤讲起，顺着这条河一路往上走，重点讲怎样在上游把它挡住。

先说结论

看着突然

中风往往在几分钟里发生，可是把人推到那一步的，是十几年、几十年慢慢积累的高血压、斑块和生活

九成可以改变

全世界 32 个国家的研究：十项可以改变的危险因素，和约九成的中风有关；第一大的是高血压

INTERSTROKE

认出它

“中风 120”：看一张脸歪不歪，查两只胳膊有没有一边没力，听说话清不清；有一项就打 120

抢时间

发病后 4.5 小时内溶栓、部分病人 24 小时内取栓，越早越好；掐人中、放血、等一等，只会耽误

中国的试验

村医帮农村高血压病人把血压降下来，三年里中风少了约三分之一；换代用盐、降压药加叶酸，也都减少了中风

CRHCP 等

中医和偏方

安宫牛黄丸、针灸、丹参，现有试验没有确认能改善结局；少数中成药有大型试验支持，还要更多验证

下面先讲中风是什么、发病时怎样和时间赛跑，再顺着河往上走：上游的几种病、上游的上游的生活和环境；然后讲中风以后怎样不再中第二次，最后按证据看中医和自然疗法。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 一个平常的早晨
  - 02 中国有多少人在这条路上
  - 03 中风是什么：堵了，或者破了
  - 04 每一分钟，都在失去
- 第二部分 · 发病的那一刻：和时间赛跑

05 认出中风：“中风 120”
06 第一件事：打 120
07 这些做法，只会耽误时间
08 到了医院：溶栓和取栓
09 如果是脑出血
10 “小中风”：最响的一次警报
第三部分 · 上游：把人推向中风的几种病
11 一条河：下游、上游、上游的上游
12 九成和这十件事有关
13 第一大上游：高血压
14 心脏里的血块：房颤
15 血管里的“垢”：血脂、血糖、吸烟
16 喝点酒，能“活血”吗
第四部分 · 上游的上游：几十年的生活和环境
17 上游的上游：几十年的生活
18 中国人的盐
19 饭桌：水果、蔬菜、坚果和好油
20 吃素的人，要注意什么
21 动起来、管住腰围、放下重担
22 年轻人和中年人：从现在开始
第五部分 · 中风以后：不再中第二次，慢慢走回来
23 不再中第二次
24 康复：慢慢走回来
第六部分 · 中医和自然疗法：哪些有证据
25 中医药：安宫牛黄丸、针灸和中成药
26 自然疗法：哪些真的有用
第七部分 · 结语与问答
27 一张预防中风的清单
28 通达人见祸藏躲
29 回到那个早晨
30 常见问题

第一部分

先把问题摆上桌

01 一个平常的早晨

王阿姨六十七岁，有高血压好些年了，药是“想起来就吃，忘了就算”。一天早上起床，她发现右手拿不住筷子，说话也有点含糊。老伴说：“昨晚没睡好吧？再躺一会儿。”儿子在外地，打电话来说：“先掐掐人中，再给她吃颗安宫牛黄丸。”

折腾了快三个小时，女儿下班回来，一看妈妈的嘴角歪了，才叫了救护车。

医生说：是中风。能不能用最有效的治疗，就差在这几个小时上。

这样的早晨，在中国每天都在发生。很多家庭事后都会问同样的问题：

- 中风怎么来得这么突然？前一天还好好的。
- 发病的时候，家里人到底该做什么、不该做什么？
- 医生说中风是“下游”，那上游是什么？上游的上游又是什么？到底能不能预防？
- 中风以后，怎样不再中第二次？中医、针灸、安宫牛黄丸，还有各种“自然疗法”，到底有没有用？

这一篇是健康栏目的第四篇。前三篇讲了高血压、糖尿病和高血脂，它们正是中风的“上游”。这一篇顺着这条河往下走，看看它们最后会流到哪里，也看看怎样在上游把它挡住。

先说结论：**中风看起来是突然来的，其实大多是一条走了几十年的路。**到了下游，只能和时间赛跑；越往上游出手，能挡住的越多。

这一篇怎样读

- **第二部分最要紧。**如果你没有时间读完整篇，请先读第 5 章《认出中风：“中风 120”》和第 6 章《第一件事：打 120》：认出中风、立刻打 120。这可能救一个人。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何用药、换药、停药，都要先问医生。

02 中国有多少人在这条路上

先看看这件事有多大。

从 2015 年起，**中风就是中国人死亡和残疾的第一位原因**[1]。全球疾病负担研究也显示，2017 年中国人的死因里，排在最前面的是中风和冠心病[2]。

目前最新的全国数据来自 2020 年。研究者在全国 31 个省，调查了 67 万多名 40 岁以上的成年人，2023 年发表：**40 岁以上的中国人里，约 2.6% 得过中风**。按这个比例推算，那一年全国约有 1780 万中风病人，新发生的约 340 万，因中风去世的约 230 万[3]。

还有两个值得注意的地方：

- **农村比城市更重。**城市里得过中风的人稍多一点，但农村每年新发中风和因中风去世的比例都比城市高[3]。
- **北方比南方更重。**2013 年一项 48 万人的全国调查发现，中风有明显的“北高南低”：每年新发中风最多的是东北，最少的是西南[4]。

2013 年那次调查还和 30 年前比了一下：中风的患病率比三十年前更高了，农村尤其明显[4]。

> **— 世界上的情况怎样？年轻人呢？**
>
> 全球疾病负担研究 2024 年发表的分析显示：2021 年，全世界约有 1190 万人新发中风，730 万人因中风去世；中风是全球第三位的死亡原因。研究者特别提到，从 2015 年起，全球中风发病率的下降停滞了，而东亚、东南亚和 70 岁以下的人群，有些指标还在上升[5]。
>
> 也就是说，中风不再只是“老年人的病”。后面会讲到，年轻人身上最常见的几个危险因素，恰恰是腰围、少动和高血压（见第 22 章《年轻人和中年人：从现在开始》）。

中风留下的，不只是死亡。2020 年的全国数据里，中风幸存者中约八分之一留下了残疾[1]；一年之内，约每 18 个出院的病人里，就有一个再次中风[1]。

这就是为什么这一篇要花最多的篇幅讲预防。

03 中风是什么：堵了，或者破了

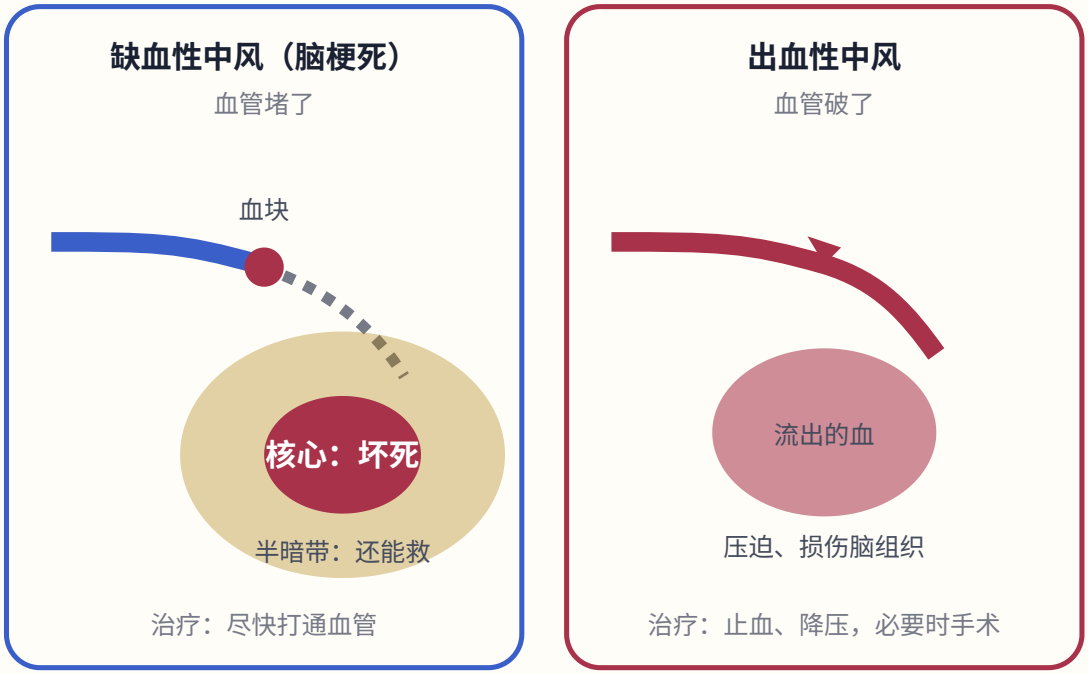
“中风”是老百姓的说法，医学上叫“脑卒中”。“卒”就是“突然”的意思。

大脑只占体重的百分之二左右，却要用掉全身很大一部分血液和氧气。它自己几乎没有储备，一旦断了血，几分钟就开始受伤。

中风有两大类：

- **缺血性中风**，也叫脑梗死：脑子里的一根血管被**堵住**了。堵它的，可能是血管壁上的斑块长大破裂后形成的血块，也可能是从心脏里冲上来的血块。
- **出血性中风**：脑子里的血管**破了**。血流进脑组织，叫脑出血；流到脑子表面的腔隙里，叫蛛网膜下腔出血。

图 1 两种中风：血管堵了，或者血管破了



两种的治疗正好相反——只有脑部 CT 或核磁共振才能分清

中国 2020 年住院病人：缺血性约 82%，脑出血约 15%，蛛网膜下腔出血约 3%

在中国，缺血性的占大多数。2020 年全国一千五百多家医院收治的约 340 万中风病人里，缺血性的约占 82%，脑出血约 15%，蛛网膜下腔出血约 3%[1]。出血性的虽然少，却更凶险：住院期间死亡或放弃治疗出院的比例，缺血性约 6.4%，脑出血约 21.8%[1]。

为什么这一点要先讲

两种中风，治疗正好相反：一种要尽快把血管打通，一种要止血、降压。**从外表看，分不出是哪一种**，只有脑部 CT 或核磁共振才能分清。所以在医院做检查以前，不要给病人自己吃任何“通血管”或“活血”的药。（编者的理解）

还有一种情况叫**“小中风”**，医学上叫短暂性脑缺血发作：症状和中风一样，却在几分钟到几小时内自己好了。很多人因此松了一口气，不去看医生。其实，这是最响的一次警报，第 10 章《“小中风”：最响的一次警报》会专门讲。

04 每一分钟，都在失去

为什么中风一定要快?

2006 年，美国的一位神经科医生做了一个计算：一次典型的大血管堵塞，没有治疗的话，**每过一分钟，大约有 190 万个神经细胞死去**，同时失去约 140 亿个神经连接；每过一小时，大脑相当于老了 3.6 岁[6]。

这当然是估算，但它说明了一件事：中风的时候，时间就是大脑。

前面图里那一圈“半暗带”，就是抢救的对象。堵住的中心很快坏死，救不回来；可周围那一圈，还靠旁边的小血管勉强撑着。血管打通得越早，能救回来的就越多；拖得越久，这一圈也一点一点变成坏死。

编者的理解

所以，中风发作的那一刻，家里人能做的最重要的一件事，不是找药、不是按穴位，而是**不耽误一分钟，把病人送到能治中风的医院**。下一部分专门讲这件事。

第二部分

发病的那一刻：和时间赛跑

05 认出中风：“中风 120”

中风常常不痛不痒，病人自己也说不清楚，所以要靠身边的人认出来。

中国的医生为普通人设计了一个好记的口诀，叫**“中风 120”**，和急救电话 120 正好一样[7]：

- **1：看 1 张脸。**让他笑一笑，看嘴角是不是一边歪、两边不对称。
- **2：查 2 只胳膊。**让他把两只胳膊平举起来，看是不是有一边没力气、慢慢往下掉。
- **0：（聆）听讲话。**听他说话是不是含糊不清、说不出来，或者听不懂别人的话。

有任何一项，**立刻拨打 120**。

还要补充两种常被忽略的表现。美国一家医院回顾了 700 多名缺血性中风病人，发现只看脸、胳膊和说话，会漏掉约 14% 的人；这些被漏掉的人，很多是**突然走路不稳、站不住**，或者**突然一只眼或两眼看不清**。把这两项加上，漏掉的降到约 4%[8]。

图 2 认出中风：“中风 120”，再加上走路不稳、眼睛看不清



记下“最后一次看到他正常”的时间，告诉医生

口诀：中国“中风 120”；补充两项据 BE-FAST 研究

还有一种表现也要留意：突然出现从来没有过的、非常剧烈的头痛。这可能是蛛网膜下腔出血，同样要马上打 120。（编者的理解，依据常见的临床表现）

给家里人的提醒

很多中风发生在夜里或清晨，病人醒来才发现。中国 2022 年的一项登记研究发现，**睡醒才发现的中风、以头晕开始的中风**，更容易送晚了[9]。早上起来如果家里老人说话、拿东西和平时不一样，不要以为“没睡醒”，先按上面三步看一看。

06 第一件事：打 120

认出了中风，下一步就是打 120。不要自己开车先去附近的小诊所，也不要先打电话问亲戚。

为什么一定要叫救护车？中国卒中中心联盟分析了 2015 到 2018 年的 56 万多名缺血性中风病人：**坐救护车来的只有 12.5%**，大多数人是家里人自己送来的。坐救护车来的人，到医院明显更早；在符合条件的病人里，也明显更容易得到溶栓治疗[10]。

2022 年的另一项研究还发现：**中途换医院**，是送晚的最大原因之一——先去了一家不能治的医院，再转院，就明显更容易拖过 3 小时。研究里只有约五分之一的病人或家属知道本地的“卒中急救地图”（标出哪些医院能做溶栓取栓），真正按地图送医的更少[9]。

等救护车的时候，可以做这几件事（编者整理）

- **记下时间。**记住“最后一次看到他正常”是几点钟。医生决定能不能溶栓、取栓，首先看这个时间。睡醒才发现的，就是前一晚睡前的时间。
- **让他躺下或靠坐着**，松开衣领；如果呕吐，让他侧过头或侧躺，免得呛进气管。
- **不要给他吃东西、喝水、吃药。**中风的人常常吞咽不好，容易呛着；而在分清是梗死还是出血以前，任何药都可能帮倒忙。
- 把平时吃的药、病历带上，告诉医生他有什么病。
- 可以提前问清楚本地哪家医院有卒中中心，告诉 120。

07 这些做法，只会耽误时间

回到开头的王阿姨。那三个小时里，家里人做的几件事，都很常见，也都是好心，但都在耽误时间。

- **“再躺一会儿、睡一觉就好了。”**中风不会睡一觉就好。症状自己消失的，也可能是小中风，更要马上看医生（见第 10 章《“小中风”：最响的一次警报》）。

- **掐人中、按穴位。**没有研究证明掐人中能治中风；病人如果意识不清，掐人中也不能把堵住的血管打通，只是拖延了出门的时间。（编者的理解）
- **十指放血、扎耳朵放血。**同样没有可靠的研究支持。缺血性中风是血管里堵了血块，从手指放几滴血，改变不了脑子里那根血管。（编者的理解）
- **先喂一颗安宫牛黄丸、降压药或阿司匹林。**前面说过，在 CT 分清是梗死还是出血以前，吃药可能帮倒忙；病人吞咽不好，还可能呛着。安宫牛黄丸本身的证据怎样，第 25 章《中医药：安宫牛黄丸、针灸和中成药》会讲。
- **自己开车，先去附近的小诊所。**如果那里不能做溶栓、取栓，还要再转院，时间就这样流走了[9]。

> **编者的理解**
>
> 这些做法背后，是一片爱心，也是一种“先想办法自己处理”的习惯。可是中风不是可以在家处理的病。**对中风来说，最有爱心的做法，就是最快地把人交给能治的医生。**如果家里有高血压、糖尿病、房颤的老人，不妨今天就把这一章讲给全家人听一听。

08 到了医院：溶栓和取栓

到了医院，医生会先做脑部 CT 或核磁共振，分清是梗死还是出血。如果是缺血性中风，而且时间来得及，有两种能把血管打通的办法。

第一种是静脉溶栓，就是打一针能把血块溶掉的药。英国牛津的研究者把 9 个随机试验、6756 名病人的资料放在一起分析[11]：

- 发病 **3 小时内**用药，三到六个月后没有明显残疾的人，用药组 32.9%，对照组 23.1%；
- **3 到 4.5 小时**用药，是 35.3% 对 30.1%；
- 超过 4.5 小时，差别就不再明显。

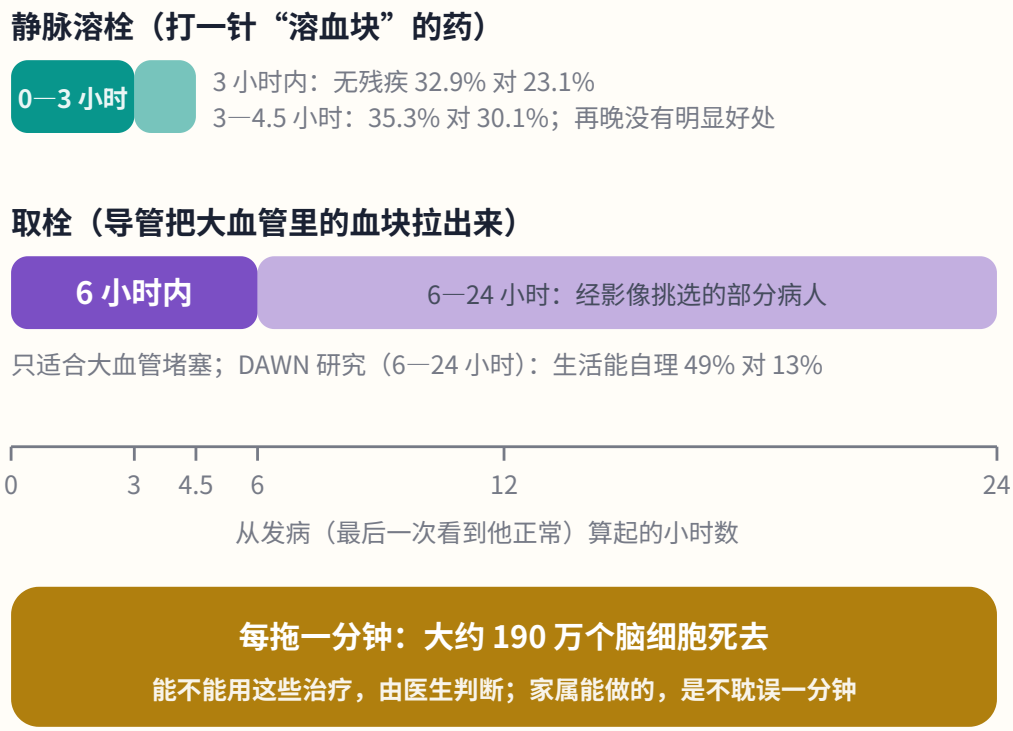
溶栓也有风险：它会增加脑出血。在这项汇总里，用药后头几天因脑出血死亡的，用药组 2.7%，对照组 0.4%。但把好处和风险放在一起算，3 小时内用药的人，三到六个月后没有残疾地活着的，平均多了约 10%；3 到 4.5 小时内用药的，多了约 5%[11]。所以医生会仔细判断谁能用。

中国也做了自己的试验。2023 年发表的 TRACE-2 研究，在全国 53 家医院比较了两种溶栓药：国产的替奈普酶和传统的阿替普酶，效果相当，出血风险也差不多[12]。替奈普酶只要推注一次，用起来更方便。

第二种是取栓：医生从大腿根部的动脉送进一根细导管，一直到脑子里，把堵住大血管的血块拉出来。五个大型随机试验的汇总显示：对大血管堵塞的病人，**平均每治疗 2.6 个人，就有一个人的残疾程度至少减轻一级**；80 岁以上的老人同样受益[13]。

取栓原来一般要在 6 小时内做。2018 年的 DAWN 研究发现：对经过特殊影像检查挑选出来的病人，6 到 24 小时内取栓，三个月后生活能自理的，取栓组 49%，对照组只有 13%[14]。

图 3 和时间赛跑：溶栓、取栓的时间窗，越早越好



数据：Emberson 2014（溶栓汇总）、DAWN 2018、Saver 2006

一 这些研究是谁资助的?

溶栓、取栓的试验，很多有药厂或器械公司的资助，我们照实注明：HERMES 汇总由一家取栓器械公司资助，DAWN 研究也是[13][14]；中国的 TRACE-2 由国家科技项目和生产替奈普酶的公司共同资助[12]。溶栓的汇总分析由英国医学研究理事会等公共机构资助[11]。这些研究都是随机对照试验，结论也被后来的研究反复确认，但读者知道资助方，是应该的。

编者的理解

能不能溶栓、取栓，要医生根据时间、影像和病人的情况来判断，家属不必自己去记这些数字。家属要记住的只有一件事：**越早到医院，这扇门开得越大；晚了，门就关上了。**

09 如果是脑出血

脑出血没有“打通血管”的问题，治疗的重点是：控制血压、防止血肿继续扩大、处理脑子里的压力，必要时做手术。具体怎样做，要由神经科和神经外科的医生决定。

前面说过，脑出血比脑梗死更凶险[1]。而它最主要的上游，就是高血压：国际研究发现，高血压和脑出血的关系，比和脑梗死的关系更强[15]。2019 年全国 1600 多家三级公立医院的住院资料里，脑出血病人约七成有高血压[16]。

喝酒也是脑出血的重要上游。中国 50 万人的研究发现，酒喝得越多，脑出血的风险越高，而且比脑梗死升得更快[17]（见第 16 章《喝点酒，能“活血”吗》）。

编者的理解

脑出血一旦发生，医生能做的有限；能做最多的，是在它发生以前，把血压管好、把酒戒掉。这又回到了上游。

10 “小中风”：最响的一次警报

有时候，中风的症状来了又走：嘴歪了十几分钟，又好了；一只手麻了半小时，又恢复了。医学上叫短暂性脑缺血发作，老百姓叫“小中风”。

很多人会想：好了就好了，不用去医院了吧？

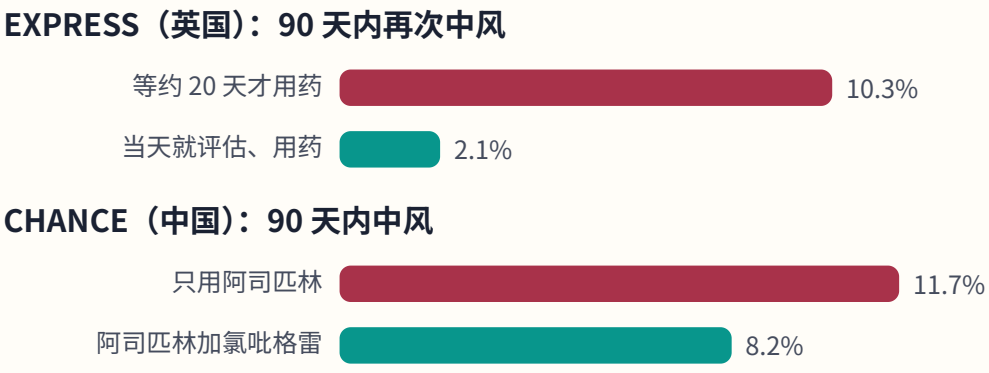
恰恰相反，这是最需要马上看医生的时候。小中风说明脑子里的血管已经出了问题，只是这一次血块自己溶开了、或者被冲走了。下一次，可能就不走了。

英国牛津的 EXPRESS 研究，比较了两种做法[18]：

- 原来的做法：病人先看社区医生，通常要等约 20 天才开始用预防的药。**90 天内再次中风的有 10.3%。**
- 改进以后：病人当天或第二天就在专科门诊评估，当场开始用药。**90 天内再次中风降到 2.1%**，少了约八成，出血也没有增加。

中国的 CHANCE 研究，在全国 114 家医院、5170 名轻微中风或高危小中风的病人身上，比较了两种用药方法：发病 24 小时内开始，阿司匹林加氯吡格雷的组，90 天内中风 8.2%；只用阿司匹林的组，11.7%。出血没有增加，两组都是 0.3%[19]。

图 4 小中风以后：越快看医生、越快用药，再次中风越少



数据：Rothwell 2007；Wang 2013（具体用哪种药，由医生决定）

一项在 21 个国家做的研究也显示：在能快速评估的医疗体系里，小中风或轻微中风以后，第 2 天再中风的约 1.5%，第 7 天 2.1%，一年 5.1%[20]。风险最集中在头几天。

请记住

“中风 120”的症状，哪怕几分钟就消失了，也要**当天去医院**，最好就打 120。用哪种药、用多久，由医生决定，不要自己在家吃阿司匹林了事。

第三部分

上游：把人推向中风的几种病

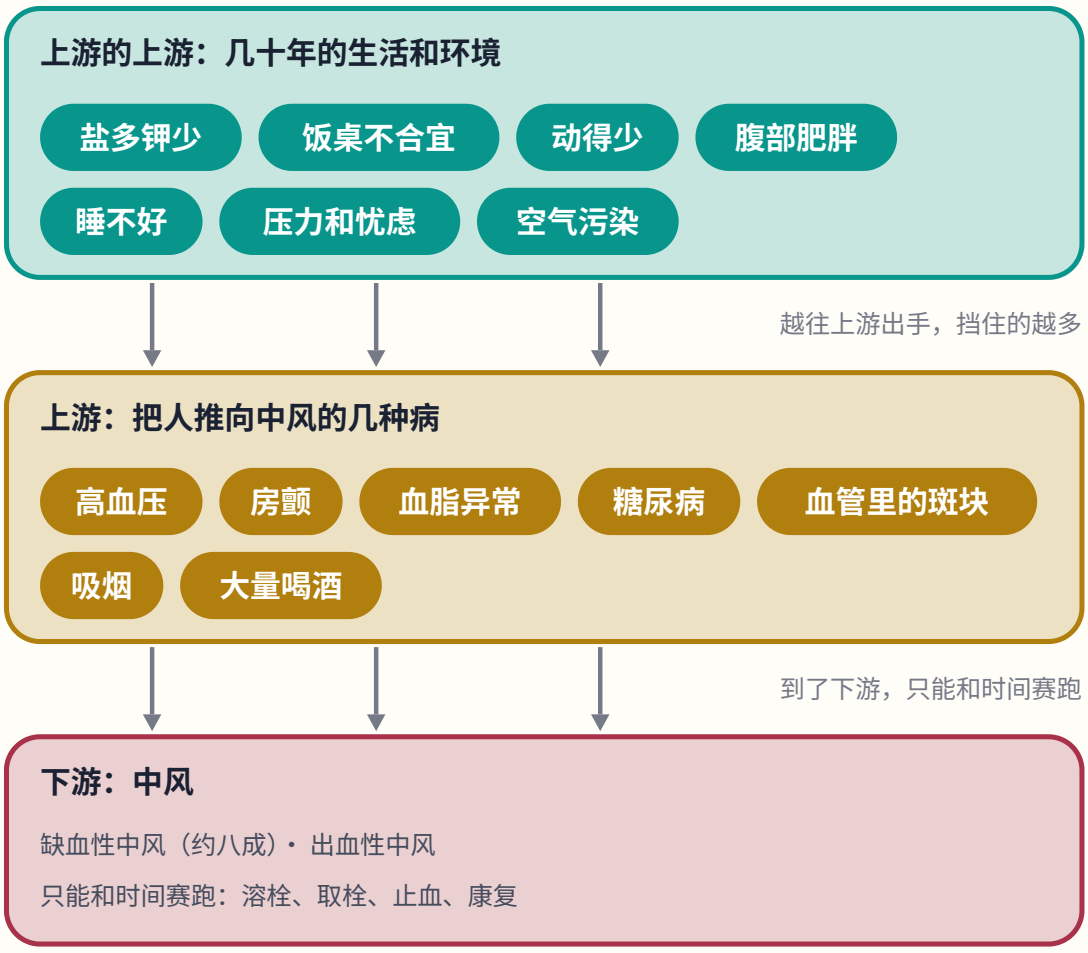
11 一条河：下游、上游、上游的上游

现在，我们从下游往上走。

中风常被说成“突然”的病。可是如果把一个人的一生摊开来看，它更像一条河的下游。

- **下游**，是中风本身。到了这里，只能和时间赛跑：溶栓、取栓、止血、康复。
- **上游**，是把人推向中风的几种病和状态：高血压、房颤、血脂异常、糖尿病、血管里的斑块、吸烟、大量喝酒。它们往往要十几年才把人推到下游。
- **上游的上游**，是造成这些病的生活和环境：盐多钾少、饭桌不合宜、动得少、腹部肥胖、睡不好、长期的压力和忧虑，还有空气污染。它们要几十年才显出后果。

图 5 中风是一条河的下游：上游是几种病，上游的上游是几十年的生活和环境



还有改不了的：年龄、性别、家族史——它们是更要小心的理由

编者整理的示意，依据 INTERSTROKE 和全球疾病负担研究

还有一些改不了的：年龄、性别、家族史。它们不是放弃的理由，而是更要小心的理由。

编者的理解

越往上游出手，挡住的越多，花的力气也越小。到了下游，即使有最好的医院，也有很多人救不回来，或者留下残疾。所以这一篇接下来的两部分，会用最多的篇幅讲上游和上游的上游。

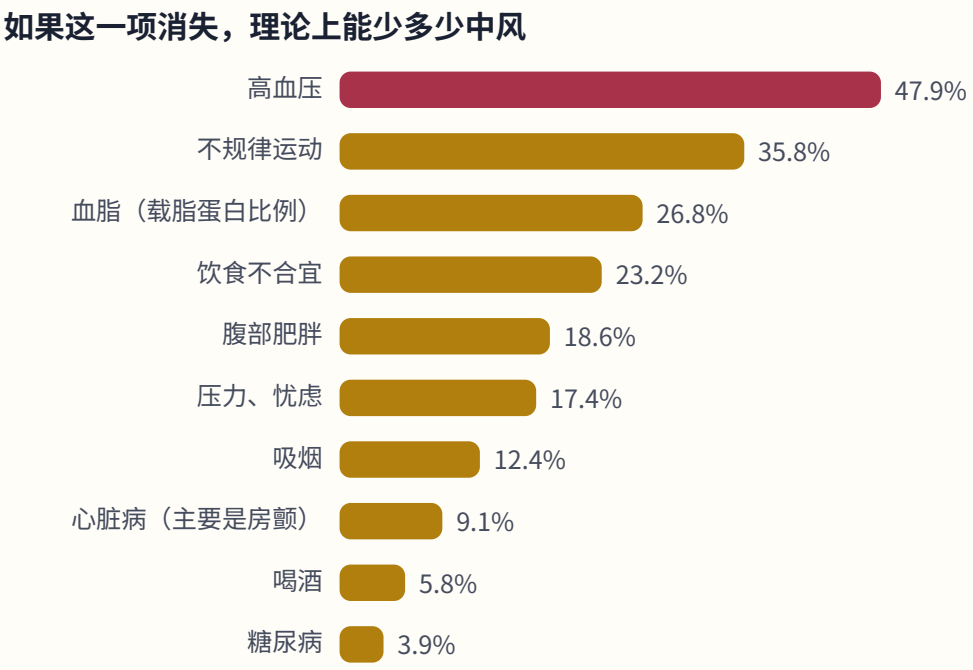
12 九成和这十件事有关

中风到底有多少是可以预防的？

国际 INTERSTROKE 研究在 32 个国家，比较了约 1.3 万名首次中风的病人和同样多的、年龄性别相当的没有中风的人。研究者找到了十项可以改变的危险因素，**合起来和全世界约 90% 的中风有关**[15]。

这十项是：高血压、缺少规律运动、血脂（载脂蛋白的比例）、饮食不合宜、腹部肥胖（腰臀比大）、心理社会压力、吸烟、心脏病（主要是房颤）、喝酒、糖尿病。

图 6 十项可以改变的危险因素，和多少中风有关（INTERSTROKE，32 个国家）



各项有重叠，不能相加；十项合起来约 90.7%（O’Donnell 等，《柳叶刀》2016）

这个比例在各个地区都差不多，从非洲的约 83% 到东南亚的约 97%；男女一样，55 岁以下和以上也一样[15]。2025 年同一个研究团队又按年龄分析：不管哪个年龄段，影响最大的都是三项——**高血压、腹部肥胖、缺少运动**[21]。

一 “和九成有关”是什么意思？

这里用的是“人群归因风险”：如果某一项危险因素在人群里完全消失，理论上能少多少中风。各项之间有重叠（例如肥胖的人常常也有高血压），所以不能把十项直接相加；研究者用专门的方法算出十项合起来约 90.7%[15]。

还要说明：这是一项“病例对照研究”，比较的是已经中风的人和没有中风的人，属于观察研究。它告诉我们“有关”，不能单独证明“因为所以”。但其中最重要的几项，例如血压，已经有大量随机试验证明：降下来，中风就少了。

编者的理解

九成，这是一个充满盼望的数字。它的意思不是“九成的人都能保证不中风”，而是：中风最主要的原因，大多在我们可以做点什么的范围之内。

13 第一大上游：高血压

十项里，高血压排第一。在 INTERSTROKE 研究里，它一项就和约一半的中风有关[15]。中国 2020 年的全国调查也显示，高血压是中风最主要的危险因素：有高血压的人，中风的可能是没有的人的约 3 倍[3]。2013 年的全国调查里，中风幸存者有高血压的高达 88%[4]。

为什么血压对脑子特别要紧？

- 长期高压冲击，让大血管壁变厚、长斑块，斑块破裂就形成血块，堵住血管；
- 脑子深处有很多细小的穿通动脉，长期高压让它们变脆、变窄：窄了，形成小的梗死；脆了，一破就是脑出血。

好消息是，降压对中风的效果，是所有预防方法里证据最硬的之一。汇总 61 万多人的分析显示：**收缩压每降低 10 毫米汞柱，中风减少 27%**[22]。

中国自己的试验更让人振奋。**中国农村高血压控制项目**（CRHCP）在 326 个村子里做了一个整群随机试验：一半的村子，由经过培训的村医按照一个简单的流程，给 40 岁以上的高血压病人开药、调药，目标是收缩压低于 130、舒张压低于 80，药品打折或免费，还有健康指导；另一半照常。三年下来，两组的收缩压相差约 23 毫米汞柱；**干预组的中风少了 34%**，心血管病死亡少了 30%，全因死亡少了 15%[23]。

代价是：血压过低的情况多了一点（1.75% 对 0.89%）[23]。所以降压要在医生的指导下进行，起身时头晕要告诉医生。

编者的理解

这个试验最打动人的地方是：它没有用什么新药，靠的是村医、简单的流程和坚持。它说明，在中国农村，把已经有的降压药真正用到病人身上，就能挡住三分之一的中风。如果你的家人有高血压，最实在的一件事，就是让他按时吃药、定期量血压。高血压怎样从根上管，请看《高血压，真的要吃一辈子药吗？》。

14 心脏里的血块：房颤

有一种中风，血块不是在脑子里长的，而是从心脏里来的。最常见的原因，是**心房颤动**，简称房颤。

房颤的时候，心房不再整齐地收缩，而是快速乱颤。血在心房的一个小角落里流得很慢，容易凝成血块；血块被冲出来，顺着血管上到脑子，就把一根大血管堵住了。这样的中风往往很重。

房颤在中国并不少见。2014 到 2016 年的一项全国调查，给 4.7 万多名 45 岁以上的人做了心电图：**约 1.8% 有房颤**，相当于全国约 790 万人；75 岁以上的人里，约每 20 个就有 1 个。可是农村的房颤病人里，只有约三分之一知道自己有；**高危的房颤病人里，只有 6% 在用抗凝药**[24]。

抗凝药有多重要？一项汇总 29 个随机试验、2.8 万人的分析显示：房颤病人用华法林这类抗凝药，**中风减少约 64%**；只用阿司匹林这类抗血小板药，只减少约 22%[25]。现在还有更方便的新型口服抗凝药。

一 怎样发现房颤?

房颤有时会心慌、乏力，但很多人一点感觉都没有。在家量血压时，如果电子血压计提示“心律不齐”，或者自己摸脉搏时快时慢、强弱不一，就应该去做一个心电图。上面的全国调查也提醒：农村居民和高龄老人，知道自己有房颤的比例更低[24]。（编者整理）

编者的理解

很多老人听说“抗凝药会出血”，就不敢吃，宁愿吃阿司匹林。可是对房颤来说，阿司匹林挡住中风的作用小得多。吃不吃、吃哪一种，要由医生按中风和出血两方面的风险来判断；但不要因为害怕，就放弃一个能挡住大半中风的办法。

15 血管里的“垢”：血脂、血糖、吸烟

还有几条上游，会让血管壁上慢慢长出斑块：

- **血脂异常。**“坏胆固醇”LDL 会钻进血管壁，一点点堆成斑块。降低 LDL，能减少缺血性中风[26]。已经中过风的人，用他汀把 LDL 降下来，再次中风也少了：国际 SPARCL 研究里，五年再次中风 11.2% 对 13.1%[27]。详细的请看《高血脂》那一篇。
- **糖尿病。**长期高血糖伤害大小血管，也常和高血压、血脂异常一起出现[15]。请看《糖尿病》那一篇。
- **吸烟。**在 INTERSTROKE 研究里，现在吸烟的人中风的可能是不吸烟的人的约 1.7 倍[15]。2013 年中国的全国调查里，中风幸存者中约一半有吸烟史[4]。

前一篇讲过，血压、血糖、血脂常常长在同一个根上：腹部的脂肪放错了地方、身体对胰岛素不灵。所以这几条上游，常常一起流向下游。

编者的理解

这正是为什么健康栏目先写了三高，再写中风。三高管好了，中风这条下游的水就少了一大半。

16 喝点酒，能“活血”吗

很多人相信：少喝一点酒能“活血”、软化血管，对心脑血管有好处。过去确实有不少观察研究发现，少量喝酒的人，心脑血管病比不喝的人还少一点。

可是，这是真的因果吗？还是因为不喝酒的人里，本来就有不少是因为生了病才戒酒的？

中国的研究给了一个很有力的回答。中国慢性病前瞻性研究跟踪了 50 多万人约十年。研究者利用了东亚人特有的两个基因：有些人天生喝了酒就脸红、难受，所以喝得少；这些基因是出生时随机分配的，就像老天爷替我们做了一个“随机试验”[17]。

结果是：

- 按自己报告的喝酒量看，确实是“少量喝的人风险最低”；
- 可是按基因推算的喝酒量看，**这个“保护作用”消失了**：酒喝得越多，中风风险就一直往上升，脑出血升得更快，血压也跟着升高[17]。

研究者的结论是：**少量喝酒能预防中风的说法，很大程度上不是真的因果；喝酒会持续地升高血压和中风风险**[17]。

编者的理解

为了血管去喝酒，是没有根据的。不喝的，不必开始；在喝的，少喝或不喝，血压和中风风险都会跟着下来。

第四部分

上游的上游：几十年的生活和环境

17 上游的上游：几十年的生活

高血压、糖尿病、血脂异常、房颤，又是从哪里来的？

除了年龄和遗传，大部分来自几十年一天天的生活，还有我们生活的环境。全球疾病负担研究对中国的分析发现，造成中国人死亡和疾病负担的前四位危险因素是：**收缩压高、吸烟、高盐饮食、室外的颗粒物空气污染**[2]。

2021 年的全球分析还发现，和 1990 年相比，与中风有关的疾病负担里，增长最快的几项是：**体重指数高、气温过高、空腹血糖高、喝含糖饮料多、活动少**[5]。

INTERSTROKE 研究里的那十项，有一半以上就是生活方式本身：缺少运动、饮食不合宜、腹部肥胖、压力和忧虑、吸烟、喝酒[15]。

下面几章，一项一项地看：盐、饭桌、运动和腰围、压力和睡眠，还有素食者特别要注意的事。

> **编者的理解**
>
> 上游的上游，有的在个人手里，例如吃什么、动不动；有的不全在个人手里，例如空气、天气、工作的压力、能不能看得起病。前一种，每个人都可以从今天开始；后一种，需要家庭、教会和社会一起关心。

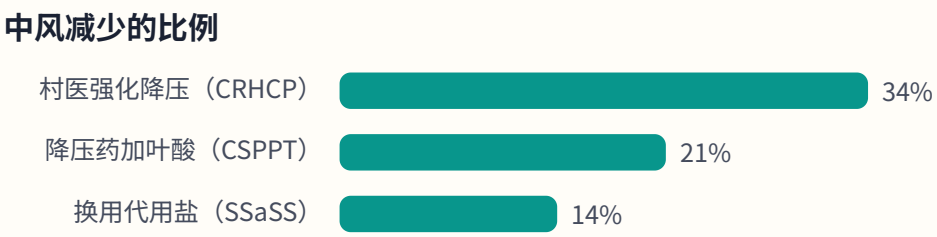
18 中国人的盐

中国人吃的盐，是世界卫生组织建议量的两倍多，而且大部分是做饭时自己加进去的（详见《高血压》那一篇）。盐多，血压就高；血压高，中风就多。

直接证明“少盐能减少中风”的，是中国自己的一个大型试验：**代用盐研究**（SSaSS）。它在中国农村的 600 个村子里，找了约 2.1 万名得过中风、或者 60 岁以上有高血压的人。一半的村子把家里的盐换成一种“代用盐”（75% 氯化钠、25% 氯化钾），另一半照常用普通盐[28]。

平均将近五年下来，**换了代用盐的村子，中风少了 14%**，主要心血管病事件少了 13%，死亡少了 12%；大家担心的高血钾，严重的不良事件两组差不多[28]。

图 7 在中国做的预防试验：中风减少了多少



数据：He 2023、Huo 2015、Neal 2021（三个都是随机对照试验）

谁要先问医生

肾功能不好的人，或者正在吃某些会升高血钾的药（例如部分降压药、保钾利尿剂）的人，用代用盐以前要先问医生。（编者的理解）

少盐还有很多不花钱的办法：做菜晚放盐；少用酱油、蚝油、豆瓣酱、味精这些“隐形的盐”；少吃咸菜、腌肉、腊肠、方便面、加工肉；在外面吃饭时请厨师少放盐。

19 饭桌：水果、蔬菜、坚果和好油

除了盐，饭桌上还有几样东西和中风关系很大。

新鲜水果。中国慢性病前瞻性研究跟踪了 45 万多名没有心血管病的成年人。那时只有 18% 的人每天吃新鲜水果。和几乎不吃的人相比，每天吃的人收缩压低约 4 毫米汞柱；**缺血性中风少约 25%，出血性中风少约 36%**，心血管病死亡少约 40%；吃得越多，风险越低[29]。这是观察研究，不能完全证明因果，但在中国人身上这么一致，很值得重视。

地中海式饮食。西班牙的 PREDIMED 是一个随机试验，找了约 7400 名心血管病高风险的人：一组吃地中海饮食并额外提供特级初榨橄榄油，一组吃地中海饮食并额外提供坚果，一组只被建议少吃脂肪。约五年下来，两个地中海饮食组的心梗、中风和心血管病死亡加起来，**比对照组少了约三成**[30]。

一 PREDIMED 为什么“撤回又重新发表”？

这个试验 2013 年首次发表后，研究者自己发现有些地方没有严格随机：例如有的家庭成员被安排在同一组、有一个研究点没有按随机表分组。他们主动撤回了原来的论文，2018 年用更严格的方法重新分析后再次发表，结论基本不变[30]。编者特别提这件事，是因为这正是科学自我纠错的样子：发现问题，公开承认，重新检验。

把这些放在一起，对中风有保护作用的饭桌，大致是：**多吃新鲜蔬菜水果、豆类、全谷物和坚果；用植物油代替动物油；少盐、少加工肉、少含糖饮料**。这和前三篇讲的方向完全一致。（编者整理）

20 吃素的人，要注意什么

本站的不少读者吃素或基本吃素。前几篇讲过，复临信徒健康研究里，吃素的人血压、血糖、血脂都较好[31][32]。那么吃素对中风也一定好吗？

这里要老老实实地说，研究结果并不完全一致。

英国的 EPIC-牛津研究跟踪了 4.8 万人约 18 年：吃素的人冠心病少了 22%，**可是中风反而多了 20%**，主要是出血性中风多了；换算成绝对数字，每 1000 人十年里约多 3 例[33]。

台湾慈济的两个研究队列却得出相反的结果：吃素的人，缺血性和出血性中风都比较少[34]。

为什么会不一样？研究者提出了一些可能的解释。台湾的研究发现，吃素的人**维生素 B12 偏低、同型半胱氨酸偏高**，而 B12 的摄入可能会影响吃素和中风的关系[34]。

中国还有一个相关的随机试验：**中国脑卒中一级预防试验**（CSPPT）在江苏、安徽找了约 2 万名高血压病人，一组吃降压药依那普利，一组吃依那普利加叶酸（0.8 毫克）。四年半下来，加叶酸的组首次中风少了 21%；研究者认为，这和中国人群原来叶酸水平偏低有关[35]。

编者的理解

这一章不是要劝人不吃素，而是提醒：**吃素要吃得均衡**。多吃新鲜蔬菜水果、豆类和全谷物；纯素食者要注意补充维生素 B12（可以问医生是否需要检查或补充）；蛋白质和各种营养要吃够。至于叶酸片，要不要吃、吃多少，请问医生，不要自己大量补充各种维生素。

21 动起来、管住腰围、放下重担

在 INTERSTROKE 研究里，**有规律运动的人，中风的可能比不运动的人低约四成**；缺少运动这一项，和约三分之一的中风有关，排在第二位[15]。

同一项研究里，**腰臀比大**（也就是腹部肥胖）和约五分之一的中风有关；而且不管哪个年龄段，高血压、腹部肥胖、缺少运动都是影响最大的三项[21]。

还有一项常被忽略的：**心理社会压力**。INTERSTROKE 研究把工作和家庭的压力、经济压力、重大的生活变故、抑郁等放在一起看，有这些压力的人，中风的可能约是没有的人的 2.2 倍[15]。这是观察研究，不能证明压力本身直接引起中风，但它提醒我们：心里的重担，也会压在血管上。

可以从今天开始的几件事（编者整理）

- **每天动一动。**快走、骑车、太极、广场舞、做家务都算；每周加起来两个半小时左右的中等强度活动，是常见的建议。老人要防跌倒，量力而行。
- **量一量腰围。**腰围比体重更能看出腹部的脂肪。腰围变小，血压、血糖、血脂常常一起变好。
- **睡好觉。**长期睡不好、打鼾憋气，都可能推高血压；打鼾很响、白天总犯困的，可以请医生看看有没有睡眠呼吸暂停。
- **放下重担。**和信得过的人说说心里的事；安息日好好休息；有长期的抑郁、焦虑，要像看身体的病一样去看医生。

22 年轻人和中年人：从现在开始

很多年轻人觉得，中风是爷爷奶奶的事。可是前面说过，全球的研究发现，东亚和 70 岁以下人群的中风，有些指标还在上升[5]。

年轻人的中风，上游常常是同样的几样：高血压、腹部肥胖、不运动、吸烟、喝酒和压力[21][15]。而且，年纪较轻的高血压病人，更不知道自己有高血压，也更少治疗[36]。

年轻时打下的底子，几十年后才显出来。血管不会记得你哪一天吃了什么，但它会记住几十年加起来的账。

给年轻人和中年人的清单（编者整理）

- 每年至少量一次血压；超过 35 岁，按医生建议查血脂、血糖。
- 不吸烟；已经吸的，越早戒越好。
- 少喝酒或不喝；不喝含糖饮料。
- 管住腰围，规律运动，少坐多走。
- 少熬夜；工作再忙，也给身体和心灵留出休息的日子。
- 家里有人很早得了中风或心梗，自己更要早检查。
- 学会“中风 120”，也教给父母。

第五部分

中风以后：不再中第二次，慢慢走回来

23 不再中第二次

得过一次中风的人，再次中风的风险比一般人高。2019 到 2020 年中国三级医院的资料显示：出院后 3 个月内再次中风的约 3.6%，一年内约 5.6%[1]。而第二次中风，往往比第一次更重。

好在，预防第二次的办法，大多有随机试验的证据：

- **降压。**PROGRESS 研究在 6105 名中风或小中风病人身上，用降压药培哚普利（必要时加吲达帕胺）治疗四年，再次中风从 14% 降到 10%，减少 28%；两种药合用的，血压降得更多，中风减少 43%。不管原来有没有高血压，都有好处[37]。
- **降脂。**他汀减少再次中风（SPARCL 研究，见第 15 章《血管里的“垢”：血脂、血糖、吸烟》）[27]。
- **抗血小板。**缺血性中风以后，医生通常会让病人长期吃阿司匹林或氯吡格雷这类药；刚发病的轻微中风，短期两种合用效果更好（CHANCE 研究，见第 10 章《“小中风”：最响的一次警报》）[19]。
- **房颤抗凝。**心脏来的血块引起的中风，要用抗凝药，阿司匹林代替不了[25]。
- **生活方式。**戒烟、戒酒、少盐、运动、管住腰围——上游的上游，一样都不能少。

> **请不要自己停药**
>
> 很多病人出院后觉得好了，药就慢慢不吃了；也有人一听说“阿司匹林伤胃”“他汀伤肝”就停掉。药有副作用，要和医生商量怎样处理，而不是自己停。停药的那一天，保护也就停了。（编者的理解）

24 康复：慢慢走回来

中风以后，很多人要面对说话、走路、吃饭、穿衣的困难。康复是一条长路，需要病人、家属和医生一起走。

康复要早，但不是越早、越猛越好。2015 年的 AVERT 研究在 5 个国家、2104 名中风病人身上，比较了两种做法：一组在发病 24 小时内就开始频繁、大量地下床活动，另一组按常规的护理。结果，**“越早越猛”的那一组，三个月后恢复得好的反而少了**（46% 对 50%）[38]。所以什么时候开始、练多少，要听康复医生的安排。

中风以后，心也会受伤。一项汇总 61 个研究、2.5 万人的分析发现：**中风以后约三分之一的人会出现抑郁**[39]。病人变得不爱说话、不想吃饭、不愿意练习，不一定是“懒”或“想不开”，可能是抑郁，需要告诉医生。

给照顾的家人（编者整理）

- 照顾中风的病人，是一件很累的事。照顾的人也需要休息、需要别人帮忙。
- 多鼓励，少替他做他自己还能做的事；一点一点的进步，都值得高兴。
- 留意吞咽：吃饭喝水容易呛的，要请医生或康复师指导吃什么、怎样吃。
- 家里防跌倒：走道通畅、浴室防滑、夜里留一盏小灯。
- 教会的弟兄姊妹可以轮流探访、帮忙，让照顾的人喘一口气。

> 你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。
>
> 加拉太书 6:2

第六部分

中医和自然疗法：哪些有证据

25 中医药：安宫牛黄丸、针灸和中成药

在中国，中风以后用中药、针灸的人非常多。它们到底有没有用？我们按证据一个个看。

安宫牛黄丸。很多家庭把它当作中风的“救命药”，有的人甚至平时就买来备着。研究的情况是这样的：

- 中文期刊里有不少小型试验和汇总分析，报告它能改善“有效率”和神经功能评分，但汇总的作者自己也说，这些研究的方法学质量不高，结论需要更多高质量研究来验证[40][41]。
- 2021 到 2022 年，中国 17 家医院做了一个随机、双盲、有安慰剂对照的试点试验（ANGONG 试验），给 117 名中重度缺血性中风的病人连用 5 天：14 天时，脑梗死和脑水肿的体积，两组没有显著差别；血里的汞和砷的变化两组差不多[40]。
- 2026 年一篇按国际标准（GRADE）评价中药随机试验的系统综述认为：安宫牛黄丸**没有显示出明确的差别**[41]。

安宫牛黄丸的传统配方里含有朱砂和雄黄，也就是含汞、含砷的矿物。上面那个试验用了 5 天，没有看到汞和砷明显升高[40]，但长期或反复服用是否安全，还缺少研究。（编者的理解）

针灸。国际循证医学协作组织（Cochrane）2018 年的系统综述，汇总了 33 个随机试验、近 4000 名急性中风病人。和“不扎针”的对照比，针灸组看起来好一些；可是**和“假针刺”比较时，这些好处都没有得到确认**，证据质量为低或很低。针灸的副作用一般较轻[42]。

丹参类制剂。Cochrane 的系统综述只找到 6 个质量很差的试验，认为不能得出可靠的结论[43]。

NeuroAiD（一种中成药胶囊）。在亚洲多国做的 CHIMES 研究，1100 名病人随机双盲，三个月后和安慰剂没有差别[44]。

也有一些中成药有了较大的随机试验支持。前面那篇 2026 年的综述，找到 9 个随机试验、1.2 万多名病人：例如**通心络**和**三七总皂苷**，在急性期的单个大型试验里改善了三个月时的功能；**脑心通**和**灯盏生脉**在预防复发的试验里减少了再次中风。但综述的作者强调：这些结果各自只有一个试验，还没有被重复验证，证据确定性从中等到很低，安全性报告也不完整，**还不足以支持常规使用**，更不能说明“中药”整体有效[41]。

还有一个值得一提的例子：**丁苯酞**。它最初来自芹菜籽里的一种成分，现在是人工合成的药。2023 年的 BAST 研究在中国 59 家医院、1216 名接受了溶栓或取栓的病人身上做了随机、双盲、安慰剂对照试验：三个月后恢复良好的，丁苯酞组 56.7%，安慰剂组 44.0%[45]。

图 8 各种治疗和做法，证据有多硬：一级一级的台阶

1　反复证实（多个大型随机试验）

及时溶栓、取栓 · 控制血压 · 房颤抗凝
他汀和抗血小板 · 少盐、不吸烟、多动

2　有大型试验支持，还要更多验证

丁苯酞 · 通心络、三七总皂苷
降压药加叶酸（叶酸偏低的人群）

3　试验质量偏低，结论不确定

针灸（对照假针刺时没有确认）· 丹参制剂
安宫牛黄丸

4　没有可靠证据，还会耽误时间

掐人中 · 十指放血 · 等等看、睡一觉
春秋“输液通血管”

评价一种疗法，不看它是“中”是“西”、“天然”还是“化学”，
只看它有没有经过公平的比较、对病人有没有真实的好处
编者按本篇引用的研究整理

编者的理解

这一章想说的不是“中医好”或“中医不好”，而是：**评价一种疗法，不看它是“中”是“西”、“天然”还是“化学”，只看它有没有经过公平的比较、对病人有没有真实的好处。**丁苯酞从芹菜籽来，经过严格的试验，就有了证据；而一些用了几百年的方子，在严格的试验里还没有显出明确的效果。

所以，如果医生在规范治疗的基础上给你开了中成药，可以问一问：这个药有没有大型随机试验？会不会和我的抗血小板药、抗凝药相互作用？**任何中药，都不能代替溶栓、取栓、降压、抗血小板这些已经证实有效的治疗。**

26 自然疗法：哪些真的有用

“自然疗法”这四个字，在中国很受欢迎，意思却很杂。有的是真正有证据的生活方式，有的是没有根据、甚至有害的偏方。我们把它分成两类来看。

有证据的“自然疗法”，其实就是前面讲过的那些：

- 少盐，换用代用盐：中风少 14%[28]。
- 多吃新鲜水果蔬菜、豆类、坚果，用好的植物油：观察研究和随机试验都支持[29][30]。
- 规律运动、管住腰围：和中风风险降低有关[15]。
- 不吸烟、不喝酒[17]。
- 叶酸偏低的高血压病人，在医生指导下补充叶酸[35]。

它们不花钱或很少花钱，副作用很小，而且一样做下去，血压、血糖、血脂常常一起变好。**这才是最值得推荐的“自然疗法”。**

没有可靠证据的，常见的有：

- **每年春秋两季去“输液通血管”。**在中国一些地方，很多老人每年定时去输几天“活血化瘀”的液体，说是能预防中风。编者在 PubMed 上没有找到支持这种做法的随机对照试验；输液本身还有过敏、感染等风险，也给心脏增加负担。预防中风，靠的是每天的降压药、降脂药和生活方式，而不是一年输几天液。（编者的理解）
- **放血、拍打、刮痧“通经络”治中风。**没有可靠的研究支持；对正在吃抗血小板药、抗凝药的人，还可能引起出血或淤青。（编者的理解）
- **各种“通血管”“溶血栓”的保健品。**它们不是药，没有经过像药物那样的试验；有的还可能非法添加药物成分。

> **编者的理解**
>
> “天然”不等于“安全”，也不等于“有效”。同样，“有效”的东西，常常就藏在最平凡的地方：一把盐少放一点，一顿饭多一份蔬菜，一天多走半小时。上帝赐给我们的“自然疗法”，大多就在饭桌上和脚底下。

第七部分

结语与问答

27 一张预防中风的清单

把前面讲的放在一起，按你现在所处的位置，大致可以这样做（编者整理；已经在用药的人，请和医生一起调整）：

你现在	最重要的几件事
年轻、各项正常	每年量一次血压；不吸烟、少喝酒；少盐、多吃蔬菜水果；规律运动、管住腰围；学会“中风 120”
有高血压	按时吃药、在家量血压，把血压控制到医生定的目标；少盐或用代用盐（先问医生）；减重、运动、戒酒
有糖尿病、高血脂	按医生意见控制血糖、血脂；三高往往同一个根，生活方式一起改
65 岁以上，或有心慌、脉搏不齐	请医生查一次心电图，看有没有房颤；有房颤的，和医生商量抗凝
吃素或基本吃素	吃得均衡；纯素食者注意维生素 B12；营养吃够
出现过“小中风”	当天去医院；按医生意见用药；之后按二级预防长期管理
得过中风	长期按时吃药，不自己停药；按康复医生的安排练习；留意情绪和吞咽；全家学会“中风 120”

无论哪一种，都要记住

看一张脸、查两只胳膊、听说话，再加上走路不稳、眼睛看不清：**有一项，就打 120。**

28 通达人见祸藏躲

箴言里有一句话，很像是为预防写的：

> 通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害。
>
> 箴言 22:3

“见祸藏躲”，不是害怕，而是看得见远处的危险，提前绕开。中风的“祸”，往往在几十年前就已经露出了苗头：一个偏高的血压，一根戒不掉的烟，一个越来越粗的腰围。通达的人，看得见这些苗头。

摩西在诗篇里祷告说：

> 求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。
>
> 诗篇 90:12

数算自己的日子，不是为了怕死，而是为了好好地用上帝所赐的每一天。照顾身体，也是数算日子的一部分。（编者的理解）

保罗提醒哥林多的信徒，身体是圣灵的殿：

> 19 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，
> 20 因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀上帝。
>
> 哥林多前书 6:19—20

这一篇讲了很多数字。但这些数字背后，是一个个家庭：一位不能再叫出孙子名字的爷爷，一位每天给老伴喂饭的奶奶。愿我们在还来得及的时候，在上游多做一点；也愿我们在下游的家庭里，多伸出一双手。

29 回到那个早晨

回到开头的王阿姨。

如果那天早上，家里人知道“中风 120”，看到她拿不住筷子、说话含糊，马上打了 120，告诉医生“早上六点半起床时就这样了”；如果她平时把降压药按时吃、把盐少放一点；如果几个月前那次手麻了半小时，她就去了医院——事情也许会很不一样。

这就是本篇想说的全部：

- 中风看起来突然，其实大多是一条走了几十年的路。它是下游。
- 上游是高血压、房颤、血脂异常、糖尿病、吸烟和喝酒；上游的上游是盐、饭桌、运动、腰围、睡眠和压力。约九成的中风，和这些可以改变的因素有关。
- 发病时，认出“中风 120”，立刻打 120，记下时间；不要掐人中、放血、喂药、等一等。
- 小中风是最响的警报，当天就要去医院。

- 中风以后，按时吃药，耐心康复，也照顾好心情。
- 中医药和各种自然疗法，要看证据：最有证据的“自然疗法”，就是少盐、多蔬果、多动、不吸烟、不喝酒。

如果你家里有高血压的老人，今天就可以做两件事：帮他量一次血压，教全家人学会“中风 120”。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。文中的研究结论都转述自已发表的论文摘要，出处见文末。

30 常见问题

怀疑家里人中风，能先给他吃一片阿司匹林吗？

不要自己给。中风分堵了和破了两种，从外表分不出来，只有 CT 或核磁共振才能分清；如果是脑出血，吃阿司匹林可能加重出血。病人吞咽不好，还可能呛着。正确的做法是立刻打 120，记下发病时间。中国医院收治的中风里，约 15% 是脑出血[1]。

安宫牛黄丸要不要在家里备着，中风时先吃一颗？

现有的随机试验没有确认它能改善中风的结局[41][40]；在 CT 以前给病人吃任何药都可能帮倒忙，还会耽误时间。比备药更重要的，是全家学会“中风 120”。

“小中风”几分钟就好了，还要去医院吗？

一定要，而且最好当天。小中风以后头几天再中风的风险最高；英国的研究显示，当天评估、立即用药，90 天内再次中风从 10.3% 降到 2.1%[18]。

每年春秋去医院输几天液，能预防中风吗？

编者没有找到支持这种做法的随机对照试验。预防中风靠的是长期控制血压、血脂、血糖，治疗房颤，加上少盐、运动、戒烟限酒这些每天的功课。

降压药吃了好几年，血压正常了，能停吗？

不要自己停。血压正常，很可能正是药在起作用。中国农村的试验里，把血压降下来的村子，中风少了约三分之一[23]。想减药，要和医生一起观察调整。

听说抗凝药容易出血，房颤病人能不能只吃阿司匹林？

对房颤来说，抗凝药减少中风约 64%，阿司匹林这类药只减少约 22%[25]。出血风险需要医生评估、定期复查，但不要因为害怕就放弃更有效的保护。

针灸对中风后的恢复有没有用？ −

和假针刺比较的试验里，针灸改善急性中风结局的效果没有得到确认，证据质量为低或很低[42]。想做针灸，可以在规范的康复治疗之外，和医生商量，但不要用它代替康复训练和药物。

吃素的人是不是更不容易中风？ −

研究结果不完全一致：台湾慈济的研究里，吃素的人中风较少[34]；英国的研究里，吃素的人出血性中风反而多一点[33]。吃素要吃得均衡，纯素食者注意维生素 B12。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Tu WJ, Wang LD; Special Writing Group of China Stroke Surveillance Report. China stroke surveillance report 2021. Mil Med Res 2023;10(1):33（PubMed 37468952） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Zhou M, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2019;394(10204):1145-58（PubMed 31248666） doi.org ↗ ↑ ↑
3. 学术研究 Tu WJ, et al. Estimated Burden of Stroke in China in 2020. JAMA Netw Open 2023;6(3):e231455（2020 年全国 31 省 676,394 名 40 岁以上成年人；PubMed 36862407） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 Wang W, et al (NESS-China). Prevalence, Incidence, and Mortality of Stroke in China: Results from a Nationwide Population-Based Survey of 480 687 Adults. Circulation 2017;135(8):759-71（2013 年全国调查；PubMed 28052979） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

5. 学术研究 GBD 2021 Stroke Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2021. Lancet Neurol 2024;23(10):973-1003（PubMed 39304265） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

6. 学术研究 Saver JL. Time is brain—quantified. Stroke 2006;37(1):263-6（PubMed 16339467） doi.org ↗ ↑

7. 学术研究 Zhao J, Liu R. Stroke 1-2-0: a rapid response programme for stroke in China. Lancet Neurol 2017;16(1):27-8（PubMed 28029517） doi.org ↗ ↑

8. 学术研究 Aroor S, Singh R, Goldstein LB. BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): Reducing the Proportion of Strokes Missed Using the FAST Mnemonic. Stroke 2017;48(2):479-81（PubMed 28082668） doi.org ↗ ↑

9. 学术研究 Su Y, et al. Analysis of prehospital delay in acute ischaemic stroke and its influencing factors: a multicentre prospective case registry study in China. Stroke Vasc Neurol 2025;10(5):637-47（2022 年 21 家医院、12,484 人；PubMed 40037663） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

10. 学术研究 Gu HQ, et al (Chinese Stroke Center Alliance). Use of Emergency Medical Services and Timely Treatment Among Ischemic Stroke. Stroke 2019;50(4):1013-6（560,447 人；PubMed 30841820） doi.org ↗ ↑

11. 学术研究 Emberson J, et al. Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet 2014;384(9958):1929-35（9 个试验、6756 人；PubMed 25106063） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

12. 学术研究 Wang Y, et al. Tenecteplase versus alteplase in acute ischaemic cerebrovascular events (TRACE-2): a phase 3, multicentre, open-label, randomised controlled, non-inferiority trial. Lancet 2023;401(10377):645-54（中国 53 家医院、1430 人；PubMed 36774935） doi.org ↗ ↑ ↑

13. 学术研究 Goyal M, et al (HERMES). Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet 2016;387(10029):1723-31（1287 人；器械公司资助；PubMed 26898852） doi.org ↗ ↑ ↑

14. 学术研究 Nogueira RG, et al (DAWN). Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med 2018;378(1):11-21（206 人；器械公司资助；PubMed 29129157） doi.org ↗ ↑ ↑

15. 学术研究 O'Donnell MJ, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet 2016;388(10046):761-75（26,919 人；PubMed 27431356） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

16. 学术研究 Wang YJ, et al. China Stroke Statistics: an update on the 2019 report. Stroke Vasc Neurol 2022;7(5):415-50（PubMed 35443985） doi.org ↗ ↑

17. 学术研究 Millwood IY, et al (China Kadoorie Biobank). Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet 2019;393(10183):1831-42（PubMed 30955975） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

18. 学术研究 Rothwell PM, et al (EXPRESS). Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke: a prospective population-based sequential comparison. Lancet 2007;370(9596):1432-42（PubMed 17928046） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 学术研究 Wang Y, et al (CHANCE). Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2013;369(1):11-9（中国 114 家医院、5170 人；PubMed 23803136） doi.org ↗ ↑ ↑

20. 学术研究 Amarenco P, et al (TIAregistry.org). One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke. N Engl J Med 2016;374(16):1533-42（21 国 4789 人；药厂资助；PubMed 27096581） doi.org ↗ ↑

21. 学术研究 Reddin C, et al. Influence of age on the association of vascular risk factors with acute stroke (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet Healthy Longev 2025;6(6):100709（PubMed 40617250） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

22. 学术研究 Ettehad D, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387(10022):957-67（123 项研究 613,815 人；PubMed 26724178） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 He J, et al. Effectiveness of a non-physician community health-care provider-led intensive blood pressure intervention versus usual care on cardiovascular disease (CRHCP): an open-label, blinded-endpoint, cluster-randomised trial. Lancet 2023;401(10380):928-38（326 个村、33,995 人；PubMed 36871573） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

24. 学术研究 Du X, et al. Atrial fibrillation prevalence, awareness and management in a nationwide survey of adults in China. Heart 2021;107(7):535-41（2014—2016 年，47,841 名 45 岁以上成年人；PubMed 33509976） doi.org ↗ ↑ ↑

25. 学术研究 Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007;146(12):857-67（29 个试验、28,044 人；PubMed 17577005） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

26. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376(9753):1670-81（PubMed 21067804） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Amarenco P, et al (SPARCL). High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006;355(6):549-59（4731 人；PubMed 16899775） doi.org ↗ ↑ ↑

28. 学术研究 Neal B, et al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death (SSaSS). N Engl J Med 2021;385(12):1067-77（中国农村 600 个村 20,995 人；PubMed 34459569） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

29. 学术研究 Du H, et al (China Kadoorie Biobank). Fresh Fruit Consumption and Major Cardiovascular Disease in China. N Engl J Med 2016;374(14):1332-43（451,665 人；PubMed 27050205） doi.org ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 Estruch R, et al (PREDIMED). Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med

2018;378(25):e34（撤回 2013 年原文后重新分析发表，7447 人；PubMed 29897866） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

31. 学术研究 Pettersen BJ, et al. Vegetarian diets and blood pressure among white subjects: results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2). Public Health Nutr 2012;15(10):1909-16（PubMed 22230619） doi.org ↗ ↑

32. 学术研究 Orlich MJ, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med 2013;173(13):1230-8（73,308 人；PubMed 23836264） doi.org ↗ ↑

33. 学术研究 Tong TYN, et al. Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up: results from the prospective EPIC-Oxford study. BMJ 2019;366:l4897（48,188 人；PubMed 31484644） doi.org ↗ ↑ ↑

34. 学术研究 Chiu THT, et al. Vegetarian diet and incidence of total, ischemic, and hemorrhagic stroke in 2 cohorts in Taiwan. Neurology 2020;94(11):e1112-21（慈济两个队列；PubMed 32102976） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

35. 学术研究 Huo Y, et al. Efficacy of folic acid therapy in primary prevention of stroke among adults with hypertension in China: the CSPPT randomized clinical trial. JAMA 2015;313(13):1325-35（20,702 人；PubMed 25771069） doi.org ↗ ↑ ↑

36. 学术研究 Lu J, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China: data from 1・7 million adults (China PEACE Million Persons Project). Lancet 2017;390(10112):2549-58（PubMed 29102084） doi.org ↗ ↑

37. 学术研究 PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001;358(9287):1033-41（PubMed 11589932） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 AVERT Trial Collaboration group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet 2015;386(9988):46-55（2104 人；PubMed 25892679） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 Hackett ML, Pickles K. Part I: frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J Stroke 2014;9(8):1017-25（61 项研究、25,488 人；PubMed 25117911） doi.org ↗ ↑

40. 学术研究 Li, et al. Safety and efficacy of Angong Niuhuang Pills in patients with moderate-to-severe acute ischemic stroke (ANGONG TRIAL): A randomized double-blind placebo-controlled pilot clinical trial. Chin Med J (Engl) 2025;138(5):579-88（17 家医院、117 人；PubMed 39501831） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

41. 学术研究 Liu, et al. Adjunctive traditional Chinese medicine for ischemic stroke: a systematic review with structured narrative synthesis and GRADE assessment of randomized controlled trials. Front Med (Lausanne) 2026;13:1884399（9 个随机试验、12,348 人；PubMed 42761006） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

42. 学术研究 Xu M, Li D, Zhang S. Acupuncture for acute stroke. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD003317（33 个随机试验、3946 人；PubMed 29607495） doi.org ↗ ↑ ↑

43. 学术研究 Wu B, Liu M, Zhang S. Dan Shen agents for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD004295（PubMed 17443544） doi.org ↗ ↑

44. 学术研究 Chen CL, et al (CHIMES). Chinese medicine neuroaid efficacy on stroke recovery: a double-blind, placebo-controlled, randomized study. Stroke 2013;44(8):2093-100（1100 人；PubMed 23780952） doi.org ↗ ↑

45. 学术研究 Wang A, et al (BAST). Efficacy and Safety of Butylphthalide in Patients With Acute Ischemic Stroke: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol 2023;80(8):851-9（中国 59 家医院、1216 人；PubMed 37358859） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录